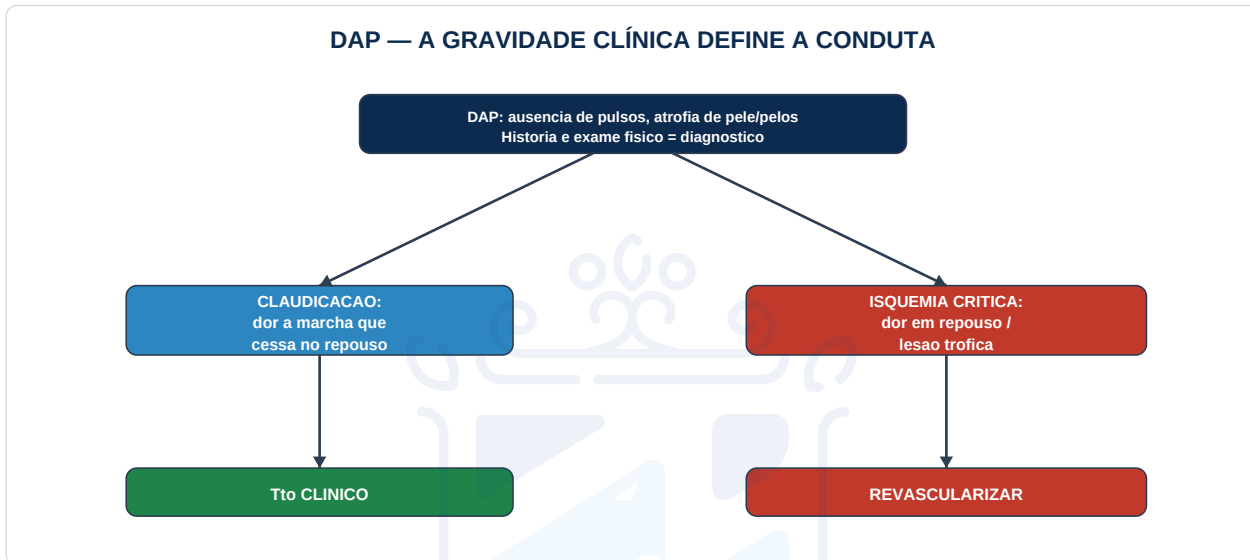


## OCCLUSÃO ARTERIAL CRÔNICA (DAP)

### FLUXOGRAMA — CLAUDICAÇÃO x ISQUEMIA CRÍTICA



### DEFINIÇÃO — ATEROSCLEROSE

#### DOENÇA SISTÊMICA

- Doença crônica inflamatória com infiltração da parede arterial (foam cells, centro necrótico, fibroateroma)
- Acomete simultaneamente vários territórios: carotídeo, coronariano, membros inferiores
- Fatores de risco: HAS, DM, hipercolesterolemia, obesidade; principal externo = TABAGISMO
- Nos MMII: atrofia da pele, ausência de pelos, sarcopenia e AUSÊNCIA DE PULSOS

### CLAUDICAÇÃO x ISQUEMIA CRÍTICA

| Aspecto       | Claudicação                              | Isquemia crítica                             |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dor           | À marcha, cessa COMPLETAMENTE no repouso | Em REPOUSO; melhora com pernas pendentes     |
| Membro        | Não ameaçado                             | Ameaçado (risco de amputação)                |
| Lesão trófica | Ausente                                  | Pode haver ferida que não cicatriza/gangrena |
| Conduta       | Tratamento CLÍNICO                       | REVASCULARIZAÇÃO + imagem                    |

### RED FLAGS — ISQUEMIA CRÍTICA

#### MEMBRO AMEAÇADO = REVASCULARIZAR

- Dor em REPOUSO (tipicamente noturna, alivia com a perna pendente)
- Lesão trófica: úlcera que não cicatriza ou gangrena
- Dois cenários: OAC descompensada (acidente de placa -> OAA aterotrombótica) ou OAC + lesão trófica infectada
- Descompensada: dor em repouso, frialdade, déficit sensitivo/motor, ± elevação de CPK/acidose/IRA
- Isquemia crítica é indicação de revascularização (não postergar avaliação vascular)

## DIAGNÓSTICO E ITB

### CLÍNICO, ITB AUXILIA

- Diagnóstico é CLÍNICO (história + exame físico); ITB não é fundamental para diagnosticar
- ITB (índice tornozelo-braço): útil para seguimento e comparação pré/pós-operatória
- ITB pode ser FALSAMENTE elevado (>1) em artérias calcificadas (DM) -> usar pressão de pododáctilo (toe pressure)
- Imagem para planejar revascularização: AngioTC (aorto-iliaco/femoro-poplíteo) ou Doppler (infragenicular)

## TRATAMENTO DA CLAUDICAÇÃO (clínico)

### Rx MODIFICADORES DE MORTALIDADE

AAS + estatina  
Alternativa: AAS + Rivaroxabana 2,5mg 12/12h + estatina  
CESSAÇÃO DO TABAGISMO (a mais importante)  
Controle de comorbidades (HAS, DM, dislipidemia)

### Rx MODIFICADORES DE DISTÂNCIA DE MARCHA

Cilostazol (melhora a distância de marcha)  
Caminhada / exercício supervisionado  
-> estímulo à formação de circulação colateral  
Colateral: hipertrofia de rede pré-existente, angiogênese, resposta à acidose

## REVASCULARIZAÇÃO (isquemia crítica)

| Estratégia       | Características                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angioplastia     | Punção + heparinização + balão ± stent (aorto-iliaco/femoro-poplíteo); dupla antiagregação no pós-op |
| Enxerto (bypass) | Anastomose término-lateral; veia safena ipsilateral devalvulada; AAS + estatina no pós-op            |
| Híbridos         | Combinam técnicas; escolha por critérios anatômicos + performance clínica                            |

## ESCORES — Wifl E GLASS

### ESTRATIFICAR PARA PLANEJAR

- Wifl (Wound, Ischemia, foot Infection): severidade CLÍNICA do membro; estima risco de amputação
- Wifl 3-4 geralmente exigem revascularização e desbridamento
- GLASS: severidade ANATÔMICA (precisa de imagem); define a melhor estratégia de revascularização e a artéria-alvo
- Ferida pequena + isquemia severa pode precisar revascularizar; ferida extensa pode tornar o membro inviável
- Planejar com base na gravidade clínica do membro + gravidade anatômica da lesão

## CONDUTA RESUMIDA

### NO PS / AMBULATÓRIO

- ☐ Claudicação = tratamento clínico (AAS + estatina + cessar tabagismo + cilostazol + exercício)
- ☐ Isquemia crítica = encaminhamento vascular para revascularização + imagem
- ☐ Diferenciar OAC descompensada (tratar como OAA — heparinizar, vascular urgente) de claudicação estável
- ☐ ITB para seguimento; toe pressure se artérias calcificadas (DM)
- ☐ Controle agressivo dos fatores de risco em todos

## MODELO DE ENCAMINHAMENTO

### RESUMO PARA REGULAÇÃO/VASCULAR

- Paciente com DAP: ( ) claudicação estável ( ) isquemia crítica (dor em repouso/lesão trófica).
- Pulsos \_\_\_\_; ITB/toe pressure \_\_\_\_; lesão trófica em \_\_\_\_; sinais de descompensação aguda: sim/não.
- Em tratamento clínico: AAS + estatina + cessação de tabagismo ± cilostazol.
- Isquemia crítica -> solicito imagem (AngioTC/Doppler) e avaliação vascular para revascularização.



SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com dor na panturrilha desencadeada pela caminhada, que cessa completamente com o repouso, pulsos diminuídos. Diagnóstico e conduta inicial?

- A) Isquemia crítica — revascularização imediata
- B) Claudicação intermitente — tratamento clínico (AAS, estatina, cessar tabagismo, cilostazol, exercício)
- C) Trombose venosa profunda — anticoagulação
- D) Insuficiência venosa — meia elástica
- E) Oclusão arterial aguda — heparina e cirurgia

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado caracteriza a isquemia crítica de membro (e não a claudicação)?

- A) Dor apenas à marcha que cessa no repouso
- B) Dor em repouso e/ou lesão trófica (úlceras/gangrena) — membro ameaçado
- C) Pulsos normais
- D) Ausência de fatores de risco
- E) Edema vespertino que melhora com elevação

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que o ITB pode ser falsamente elevado no diabético, e qual a alternativa?

- A) Por anemia; usar hematócrito
- B) Por calcificação arterial (artérias incompressíveis); usar a pressão de pododáctilo (toe pressure)
- C) Por desidratação; repor volume
- D) Por febre; usar termômetro
- E) Não há alteração no diabético

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quais intervenções modificam a MORTALIDADE na doença arterial periférica?

- A) Cilostazol e caminhada
- B) AAS + estatina + cessação do tabagismo (e controle de comorbidades)
- C) Apenas meia elástica
- D) Anticoagulação plena isolada
- E) Repouso absoluto

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre os escores Wifl e GLASS na isquemia crítica, é correto:

- A) Wifl avalia a anatomia vascular e dispensa imagem
- B) GLASS avalia a severidade ANATÔMICA (precisa de imagem) e define a estratégia de revascularização; Wifl estima a severidade clínica/risco de amputação
- C) Ambos avaliam apenas a glicemia
- D) Wifl define a artéria-alvo da revascularização
- E) Nenhum tem utilidade clínica

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor à marcha que cessa completamente no repouso é claudicação intermitente (DAP), cujo tratamento é clínico: AAS + estatina, cessação do tabagismo, cilostazol e exercício/caminhada para estimular colaterais.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

Isquemia crítica = dor em repouso e/ou lesão trófica (úlceras/gangrena), com membro ameaçado e risco de amputação — indicação de revascularização, diferente da claudicação (membro não ameaçado).

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

No diabético, a calcificação da camada média torna as artérias incompressíveis, elevando falsamente o ITB ( $>1$ ). A pressão de pododáctilo (toe pressure) é mais fidedigna nesse cenário.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

Modificam mortalidade: AAS + estatina, cessação do tabagismo e controle de comorbidades (pode-se associar AAS + rivaroxabana 2,5mg). Cilostazol e exercício melhoram a distância de marcha, mas não a mortalidade.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

GLASS avalia a severidade anatômica (exige imagem) e orienta a estratégia/artéria-alvo de revascularização; o Wifl estratifica a gravidade clínica do membro e o risco de amputação (avalia a anatomia só indiretamente).

SM24  
Suporte ao Plantão Médico